

INFORME DESCRIPTIVO

Movilidad segura en Costa Rica

Evolución de datos, riesgos y estrategias de prevención en los Planes
Nacionales de Desarrollo e Inversión Pública, 1990–2030

Análisis longitudinal de diseño de política pública y gestión

Corpus documental de Costa Rica

Fecha de corte: 1 de septiembre de 2026

Resumen ejecutivo

Este informe describe cómo los PND y PNDIP de Costa Rica han abordado la movilidad segura entre 1990 y 2030. La investigación identifica evidencia sustantiva en nueve de diez períodos. El período 1990–1994 permanece indeterminado porque sus tomos son escaneos sin una capa textual confiable; esta limitación no se interpreta como ausencia de política.

Hallazgo central Desde 1994–1998 se observa un enfoque preventivo amplio que combina comportamiento, vehículo, infraestructura, peatones y gestión vial. La evolución posterior fortalece indicadores, metas, focalización territorial y responsabilidades, pero no mantiene una trayectoria lineal de mayor ambición o mayor evaluabilidad.

La evolución puede resumirse en cuatro grandes transiciones: de un repertorio preventivo general a metas de mortalidad; de metas nacionales a intervenciones territorializadas; de seguridad vial como programa sectorial a movilidad y seguridad vial como objetivo integrado; y, finalmente, del PNDIP como contenedor principal hacia una arquitectura en la que varios componentes se remiten a planes sectoriales e institucionales.

- El PND 1994–1998 contiene la primera evidencia sustantiva recuperada: educación vial, señalización, revisión vehicular, infraestructura peatonal e intervención de áreas críticas.
- El período 2002–2006 combina mortalidad, fiscalización de alcohol y velocidad, señalización, licencias, prevención desde salud y financiamiento.
- El PND 2015–2018 presenta el diagnóstico causal y la arquitectura programática más completos del corpus.
- El PND 2019–2022 propone contener, no reducir, la tasa de mortalidad en 17,6 por 100.000 habitantes.
- El PNDIP 2023–2026 retoma una trayectoria descendente en muertes absolutas, pero contiene una contradicción entre 700 y 702 muertes para 2026.
- El PNDIP 2027–2030 remite la política general a otros instrumentos, aunque incorpora proyectos concretos para reducir la exposición peatonal al atropello.

1. Alcance y método

El objeto de análisis es la política planificada: cómo cada plan define el problema, identifica riesgos, propone estrategias, asigna instituciones y establece indicadores, metas y recursos. El informe no determina cumplimiento, ejecución presupuestaria ni impacto observado. Para hacerlo se necesitarían estadísticas oficiales, informes de seguimiento, presupuestos ejecutados y evaluaciones externas.

Los PDF digitales se extrajeron preservando su estructura y se verificaron contra las páginas fuente. Los PDF con OCR ruidoso se utilizaron para localizar contenido, pero la imagen se mantuvo como autoridad. La plataforma web 2002–2006 se procesó como un conjunto relacional de fichas. Toda cifra citada conserva su forma literal; las unidades contradictorias y las remisiones a documentos externos se registran como incidencias.

Regla de interpretación Una meta expresa intención programática. No se presenta como resultado logrado. Asimismo, una menor presencia textual en un PNDIP no equivale automáticamente a una menor prioridad cuando el propio plan remite la materia a otros instrumentos.

2. Panorama evolutivo

Período	Rasgo dominante	Hallazgo descriptivo
1990-1994	Cobertura no resuelta	No se confirmó un bloque específico; no debe codificarse como ausencia.
1994-1998	Prevención sistémica	Educación, señalización, revisión vehicular, peatones e intersecciones críticas.
1998-2002	Continuidad programática	Ampliación e intensificación de programas de seguridad vial.
2002-2006	Granularidad e intersectorialidad	Metas, control, ingeniería, licencias, salud y financiamiento.
2006-2010	Meta nacional de efecto	Reducción de 14,2 a 12,1 muertes por 100.000 habitantes.
2011-2014	Focalización territorial	Diez tramos/cantones de alta concentración de accidentes.
2015-2018	Diagnóstico causal	Programa completo con indicador, metas, presupuesto, riesgo y responsable.
2019-2022	Integración con movilidad	Meta constante de 17,6: contención en lugar de reducción.
2023-2026	Muertes absolutas	Trayectoria descendente; contradicción interna de 700 frente a 702.
2027-2030	Desplazamiento instrumental	Política remitida a otros planes; proyecto peatonal concreto en Ruta 32.

Fuente: elaboración propia a partir del corpus local de PND/PNDIP y la base estructurada de movilidad segura.

3. Evolución por período

3.1 PND 1990–1994

Encuadre. Cobertura temática indeterminada.

Evidencia y estrategias. Los tres tomos son escaneos. La revisión visual confirmó la arquitectura sectorial y la coordinación del MOPT en infraestructura de apoyo, pero no permitió confirmar un bloque específico de seguridad vial.

Lectura de política pública. El período debe permanecer como brecha de cobertura. Presentarlo como ausencia generaría una falsa discontinuidad al inicio de la serie.

Fuente: PND 1990–1994, tomos I–III; revisión visual dirigida. Incidencia abierta de cobertura.

3.2 PND 1994–1998

Encuadre. La seguridad se incorpora dentro de un sistema de transporte eficiente y seguro.

Evidencia y estrategias. El plan diagnostica alta accidentabilidad y propone educación vial, responsabilidad de conductores y peatones, señalización y demarcación, revisión periódica de la flota, aceras, pasos peatonales, paradas y mejora de intersecciones y áreas críticas.

Lectura de política pública. La formulación es sustantivamente amplia y anticipa una lógica sistémica. Su debilidad es evaluativa: el fragmento no contiene indicador, línea base numérica, meta temporal, presupuesto o responsable.

Fuente: PND 1994–1998, páginas físicas 123–124, páginas impresas 102–103.

3.3 PNDH 1998–2002

Encuadre. Continuidad de la seguridad vial como línea de infraestructura y transporte.

Evidencia y estrategias. Se verifica la ampliación e intensificación de los programas de seguridad vial, junto con señalamiento vial y mejora del transporte remunerado de personas.

Lectura de política pública. El texto confirma continuidad, pero el OCR ruidoso y el limitado detalle de la página recuperada impiden reconstruir metas o recursos con seguridad.

Fuente: PNDH 1998–2002, tomo I, página física 92, página impresa 86.

3.4 PND 2002–2006

Encuadre. La planificación adquiere granularidad, metas anualizadas e intersectorialidad.

Evidencia y estrategias. Las fichas incluyen reducción de mortalidad, operativos de alcohol y velocidad, demarcación y señalamiento, licencias, pruebas prácticas, prevención financiada por el INS y promoción de salud. La mortalidad pasa de una línea base de 16,7 en 2001 a una meta de 13,16 por 100.000 habitantes en 2006.

Lectura de política pública. La reducción planificada es de aproximadamente 21,2 %, pero no demuestra cumplimiento. El período revela dificultades típicas de gestión de datos: metas compuestas, diferencias entre meta financiera y tabla presupuestaria, y un duplicado exacto por capitalización de ruta.

Fuente: plataforma PND 2002–2006; fichas a229, a388, a389, a980, a973_1, a973_2 y A161_2.

3.5 PND 2006–2010

Encuadre. Consolidación de una meta nacional de efecto.

Evidencia y estrategias. El plan busca reducir la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito de 14,2 a 12,1 por 100.000 habitantes para 2010.

Lectura de política pública. La ambición equivale a una reducción planificada cercana al 14,8 %. La métrica permite comparación conceptual con 2002–2006, aunque no debe asumirse que las líneas base o metodologías sean idénticas.

Fuente: PND 2006–2010, página física 67.

3.6 PND 2011–2014

Encuadre. Paso de la meta nacional a la focalización territorial y operativa.

Evidencia y estrategias. El programa propone intervenir diez tramos en cantones con mayor concentración de accidentes con heridos y muertos. Identifica COSEVI, CONAVI, CTP y MOPT, además de fuentes del BID, COSEVI y MOPT.

Lectura de política pública. La focalización fortalece la capacidad de gestión porque define dónde actuar. Sin embargo, el indicador —número de tramos intervenidos— mide producto, no reducción de mortalidad o lesiones en esos sitios.

Fuente: PND 2011–2014, página física/impresa 190 y nota de cantones.

3.7 PND 2015–2018

Encuadre. Mayor desarrollo de la teoría causal y la arquitectura programática.

Evidencia y estrategias. El diagnóstico incorpora motorización, motocicletas, peatones, velocidad, alcohol, piques, cinturón, cansancio, diseño vial, estándares de infraestructura, educación, cultura, contratación e inversión. El Programa 1.8 contiene indicador, metas anuales, presupuesto, responsable y riesgo de coordinación.

Lectura de política pública. La línea base aparece como “2013: 13,66%”, aunque el indicador se define por 100.000 habitantes. La contradicción se conserva. Bajo la unidad del encabezado, la meta 10,75 para 2018 implicaría una reducción planificada cercana al 21,3 %.

Fuente: PND 2015–2018, páginas físicas 400–403 y 415.

3.8 PNDIP 2019–2022

Encuadre. Integración conceptual entre movilidad y seguridad vial, con menor ambición de efecto.

Evidencia y estrategias. El programa busca detener el crecimiento de las defunciones. La línea base preliminar es 17,6 por 100.000 habitantes y la meta permanece en 17,6 para cada año 2019–2022. Se asignan ₡14.212,02 millones del Fondo de Seguridad Vial y COSEVI figura como responsable.

Lectura de política pública. La continuidad de la unidad no equivale a continuidad de ambición. El objetivo explícito es contención y no reducción.

Fuente: PNDIP 2019–2022, página física 259; contexto sectorial en páginas 161–164.

3.9 PNDIP 2023–2026

Encuadre. Cambio desde una tasa poblacional hacia cantidad absoluta de muertes.

Evidencia y estrategias. La línea base es 802 muertes en 2019 y las metas son 777, 751, 727 y 702 entre 2023 y 2026. El resumen sectorial, sin embargo, indica 700 muertes para 2026.

Lectura de política pública. La matriz implica una reducción planificada de 100 muertes, cerca del 12,47 %. El resumen implicaría 102 muertes, cerca del 12,72 %. La contradicción no debe resolverse silenciosamente. El cambio de unidad interrumpe la serie directa con períodos anteriores.

Fuente: PNDIP 2023–2026, páginas físicas 280 y 282; página impresa 281 para la matriz.

3.10 PNDIP 2027–2030

Encuadre. La cobertura general se desplaza hacia otros instrumentos de planificación.

Evidencia y estrategias. El sector indica que seguridad vial y reducción de accidentes se atienden mediante el PMRML 2035, el PNT 2011–2035, el PEN 2050, el PES, el Hub de Proyectos y planes institucionales. El PNDIP mantiene un proyecto para construir diez puentes peatonales en Ruta 32 y reducir la exposición al atropello.

Lectura de política pública. La menor densidad temática dentro del PNDIP no demuestra menor prioridad. El proyecto peatonal es altamente trazable, pero mide infraestructura construida, no uso de los puentes ni reducción de atropellos.

Fuente: PNDIP 2027–2030, páginas físicas/impresas 57 y 268.

4. Hallazgos longitudinales

4.1 Del repertorio preventivo a la medición de mortalidad

En 1994–1998 la política se expresa mediante un conjunto de tareas. Desde 2002–2006 adquiere líneas base y metas de mortalidad. Entre 2006 y 2022 predomina la tasa por 100.000 habitantes, mientras 2023–2026 adopta cantidades absolutas y 2027–2030 utiliza un producto de infraestructura. Esta alternancia cambia el objeto de rendición de cuentas: efecto poblacional, producto territorial o entrega física.

4.2 De la cobertura nacional a territorios y usuarios concretos

La focalización se vuelve explícita en carreteras de alto riesgo, diez cantones/tramos de alta incidencia y la Ruta 32. Los peatones aparecen desde 1994 como sujetos de educación e infraestructura y se convierten en población objetivo formal en 2027. Los motociclistas adquieren peso diagnóstico en 2015. La evidencia no muestra una continuidad equivalente para ciclistas, niñez, personas mayores o personas con discapacidad.

4.3 De una política sectorial a una red institucional

COSEVI se consolida como actor central, acompañado por MOPT, CONAVI, CTP y Policía de Tránsito según la intervención. En 2015 la coordinación deja de ser solo una condición implícita y aparece como riesgo de implementación. En 2027 la multiplicación de planes externos hace que la gobernanza sea más distribuida, pero también menos observable desde un solo documento.

4.4 Evaluabilidad creciente, pero no lineal

Las matrices modernas incorporan metas, responsables y recursos, pero también presentan problemas: unidad ambigua en 2015–2018, meta constante en 2019–2022, contradicción 700/702 en 2023–2026 y remisiones externas en 2027–2030. Un documento más estructurado no necesariamente ofrece una visión más completa de la política.

5. Indicadores, metas y comparabilidad

Período	Indicador	Meta	Advertencia
2002–2006	Mortalidad/100.000	16,7 → 13,16	Meta planificada; no resultado.
2006–2010	Mortalidad/100.000	14,2 → 12,1	Verificar metodología de la serie.
2011–2014	Tramos intervenidos	10	Producto, no efecto.
2015–2018	Mortalidad/100.000	13,66 → 10,75	Línea base impresa con signo %.
2019–2022	Mortalidad/100.000	17,6 cada año	Contención, no reducción.
2023–2026	Muertes absolutas	802 → 702	Resumen alternativo: 700.
2027–2030	Puentes acumulados	0 → 10	Entrega física, no atropellos evitados.

Nota: tasas, cantidades absolutas y productos se mantienen como series distintas.

6. Implicaciones para política pública y gestión

- Complementar indicadores de producto con resultados de seguridad: un tramo o puente construido no informa por sí solo si disminuyeron lesiones o muertes.
- Mantener simultáneamente tasas y cantidades absolutas, documentando población, año base y metodología para preservar comparabilidad.
- Formalizar poblaciones objetivo por modo de transporte y no limitarse a menciones generales de usuarios vulnerables.
- Vincular diagnóstico causal, intervención, indicador, presupuesto, responsable, riesgo y mecanismo de seguimiento en una misma cadena de resultados.
- Cuando la política se remita a instrumentos externos, incorporar referencias accesibles, versiones, fechas y correspondencia exacta con las metas del PNDIP.
- Distinguir presupuesto programado, meta de asignación y gasto ejecutado; ninguno debe sustituir al otro.
- Preservar las contradicciones del documento como incidencias auditables y resolverlas mediante fe de erratas o ficha técnica oficial, no por inferencia analítica.

7. Conclusiones

La evolución de la movilidad segura en los PND/PNDIP costarricenses no es una simple progresión desde ausencia hacia sofisticación. La evidencia recuperada muestra que ya en 1994–1998 existía una concepción preventiva amplia. Las décadas siguientes agregaron métricas, metas, focalización territorial y arreglos institucionales, pero también cambiaron unidades, niveles de resultado y fronteras documentales.

El punto de mayor articulación causal y programática se encuentra en 2015–2018. Después, la política se integra más claramente con el concepto de movilidad: primero con una meta de contención en 2019–2022, luego con una reducción en muertes absolutas en 2023–2026 y finalmente con una combinación de remisión a otros instrumentos y proyectos puntuales en 2027–2030.

El corpus permite describir con rigor el diseño de política y su evaluabilidad. No permite concluir si las estrategias fueron ejecutadas o si redujeron efectivamente muertes y lesiones. La siguiente etapa debe enlazar las metas planificadas con series oficiales comparables, presupuestos ejecutados e informes de seguimiento.

Conclusión operativa La continuidad temática existe, pero cambia de forma: programa, meta de efecto, intervención territorial, objetivo de movilidad o remisión a instrumentos externos. La comparación válida debe seguir esas transformaciones sin confundirlas con desempeño.

Fuentes documentales y productos de respaldo

- Planes Nacionales de Desarrollo y Planes Nacionales de Desarrollo e Inversión Pública de Costa Rica, períodos 1990–2030, corpus local inventariado.
- PLAN_METODOLOGIA_ANALISIS_MOVILIDAD_SEGURA_PND_PNDIP.md.
- INVESTIGACION_MOVILIDAD_SEGURA_PND_PNDIP_1990_2030.md.
- CONFIG_ANALISIS_MOVILIDAD_SEGURA.json e INVESTIGACION_RESUMEN.json.
- Quince conjuntos JSONL de cribado, evidencia, intervenciones, riesgos, indicadores, metas, financiamiento, instituciones, poblaciones, terminología e incidencias.